MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

REPUBLICA DEL PERU

Nº 491 -2025-DG-INCN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 03 de diciembre de 2025

Visto, el expediente N° 25-022218-001, que contiene el INFORME N° 0139-2025-DE-INCN/MINSA, del Departamento de Enfermería, INFORME N° 319-2025-UO-OEPE/INCN, de la Unidad de Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, PROVEÍDO N° 284-2025-OEPE/INCN, de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, y;

P.D. RODRIGUEZ G.

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud, dispone que "La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo". La protección de la salud es de interés público, por tanto, es responsabilidad del Estado, regularla, vigilarla y promoverla";

Que, la Ley N° 27658, Ley del Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus Modificatorias, en su numeral 1.1, del artículo 1°, CAPITULO I, establece Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, asimismo en el artículo 2° tiene como objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias;

Que, el artículo 126° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA, menciona al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en su literal f); como Instituto especializado, son órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, dependientes de la Dirección General de Operaciones en Salud, así como servicios de salud altamente especializados en Salud;

L. LOZANO V.

Que, el artículo 5° del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2006-SA, establece que los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben contar en cada área, unidad orgánica o servicios con manuales de procedimientos, guías de práctica clínica referidos a la atención de pacientes, personal, suministros, mantenimiento, seguridad y otros que sean necesarios, según sea el caso, en tal sentido, el inciso s) del artículo 37° del citado Reglamento Interno establece que corresponde al Director Médico disponer la elaboración del Reglamento Interno, de las guías de práctica clínica y de los manuales de procedimientos referido a la atención de los pacientes, personal suministro, mantenimiento, seguridad y otros que sean necesarios;

L. SAAVEDRA R.

Que, mediante, Resolución Ministerial N° 787-2006-MINSA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en su artículo 5° del Título I, tiene por objetivo establecer la Organización del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, normando su naturaleza, visión, misión y objetivos funcionales generales, estructura orgánica y objetivos funcionales de sus Unidades Orgánicas;

Que, el artículo 44° establece que el Departamento de Enfermería es la Unidad Orgánica Encargada de lograr el apoyo técnico especializado para la atención integral, oportuna y permanente, en el proceso de protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes, en la atención ambulatoria, hospitalización e intervenciones quirúrgicas, de acuerdo al diagnóstico y tratamiento médico prescrito; depende de la Dirección General;

P.D. RODRIGUEZ G.

Que, el INFORME N° 0139-2025-DE-INCN/MINSA, del 21 de noviembre de 2025, la Jefa del Departamento de Enfermería, remite la Guía Técnica de Procedimiento: "Movilización Temprana en Pacientes Post Operado", elaborado y presentado por el Departamento de Enfermería; adjuntando el proyecto, para su evaluación y aprobación mediante acto resolutivo;

Que, el artículo 13° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, aprobado con Resolución Ministerial N° 787-2006/MINSA, establece que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico es la unidad orgánica encargada entre otros, de lograr el diagnóstico y análisis organizacional para formular y mantener actualizados los documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes para organizar el Instituto Especializado;

Que, a través del INFORME N° 319-2025-UO-OEPE/INCN, del 25 de noviembre de 2025, el Jefe de la Unidad de Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, emite opinión técnica favorable acerca Documento Normativo - Guía Técnica de Procedimiento: "Movilización Temprana en Pacientes Post Operado", elaborado y presentado por el Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas para su aprobación mediante acto resolutivo, informe que es refrendado con el PROVEÍDO N° 284-2025-OEPE/INCN, por el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 826-2021/MINSA se aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud" que tiene por finalidad fortalecer el rol de Rectoría del Ministerio de Salud, ordenando la producción normativa de la función de regulación que cumple como Autoridad Nacional de Salud (ANS) y el objetivo de establecer las disposiciones relacionadas con las etapas de planificación, formulación o actualización, aprobación, difusión, implementación y evaluación de los Documentos Normativos que expide el Ministerio de Salud; así como específicamente de establecer la aplicación de etapas estandarizadas, transparentes y explícitas para la emisión de (DN), y brindar herramientas que facilite el desarrollo de sus funciones normativas;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 077-2023-DG-INCN, se resuelve aprobar la Directiva Administrativa: "Lineamientos para la Elaboración, Formulación y Aprobación de Documentos Normativos y Planes Específicos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas", ello con el objetivo general de establecer criterios técnicos, disposiciones y lineamientos metodológicos, que faciliten la determinación, seguimiento, medición, análisis y mejora de los procedimientos para maximizar las etapas de planificación, formulación, actualización, aprobación, difusión, implementación y evaluación;

L. LOZANO V.

Que, el numeral 5.3 de la V Disposiciones Generales, define al Documento Normativo (DN) a todo aquel documento aprobado por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que tiene por finalidad transmitir información estandarizada y aprobada sobre aspectos técnicos, sean estos asistenciales, sanitarios y/o administrativos y facilita un adecuado desarrollo de competencias, funciones, procesos, procedimientos y/o actividades, en los diferentes niveles de atención de salud, según corresponda;

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

REPUBLICA DEL PERU

Nº 491 -2025-DG-INCN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 03 de diciembre de 2025

Que, el subnumeral 5.3.7 del numeral 5.3. de la V Disposiciones Generales, define a la Guía Técnica como el Documento Normativo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, con el que se define por escrito y de manera detallada al desarrollo de determinados procesos, procedimientos y actividades administrativas, asistenciales o sanitarias. En ella se establecen metodologías, instrucciones o indicaciones que permite al operador seguir un determinado recorrido, orientándolo al cumplimiento del objetivo de un proceso, procedimientos o actividades, y al desarrollo de una buena práctica. Las Guías Técnicas pueden ser del campo administrativo, asistencial o sanitario;

P.D. RODRIGUEZ G.

Que, la Guía Técnica de Procedimiento: "Movilización Temprana en Pacientes Post Operado", tiene por finalidad de estandarizar y unificar criterios técnicos, brindar estrategias seguras de rehabilitación por parte del personal de enfermería que favorezcan a la funcionalidad del paciente reduciendo las escuelas e incidencias de eventos adversos a través de la movilización temprana, garantizando la seguridad de la calidad y eficiencia de los cuidados prestados al paciente post operado hospitalizado del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; asimismo tiene como objetivo general aportar un conjunto de recomendaciones técnicas basadas en evidencias científicas a los profesionales de enfermería en el proceso de movilización temprana en el paciente post operado, reduciendo eventos adversos y complicaciones mejorando la calidad de vida promoviendo la calidad del cuidado;

Que, estando a lo propuesto por el Departamento de Enfermería y lo opinado por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, con INFORME N° 569-2025-OAJ/INCN, del 01 de diciembre de 2025;

Con los vistos del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, de la Jefa del Departamento de Enfermería y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas;

Que, conforme al literal g) del artículo 11° del Título III, del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, aprobado por Resolución Ministerial N° 787-2006/MINSA, establece las atribuciones y responsabilidades del Director General es expedir resoluciones directorales en los asuntos de su competencia;

L. LOZANO V.

De conformidad con, Ley N° 26842 – Ley General de Salud, Ley N° 27658, Ley del Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus Modificatorias, Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, Resolución Ministerial N° 787-2006- MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y Resolución Ministerial N° 001-2025/MINSA, artículo 13°, numeral 13.1 que delega facultades a diversos funcionarios del Ministerio de Salud durante el año fiscal 2025, disponer que la aprobación que se expida mediante acto resolutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1° APROBAR la Guía Técnica de Procedimiento: "Movilización Temprana en Pacientes Post Operado", que a dieciocho (18) folios forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2° ENCARGAR a la Jefa del Departamento de Enfermería la implementación, aplicación, monitoreo, supervisión y cumplimiento de la Guía Técnica de Procedimiento: "Movilización Temprana en Pacientes Post Operado", en el ámbito de su competencia.

Artículo 3° DEJAR SIN EFECTO todo acto resolutivo que se oponga o contravenga la presente Resolución Directoral.

Artículo 4° DISPONER que la Oficina de Comunicaciones efectúe la publicación y difusión de la presente Resolución Directoral en el Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. Esp. LUIS JAIME SAAVEDRA RAMIREZ
Director General
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

LJSR/LMLV/JJCS/DRF/ERSC/PDRG/mcs

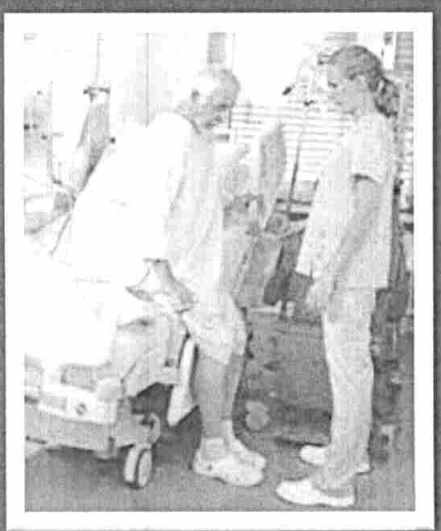
INCN

PERÚ | Ministerio de Salud | Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO: "MOVILIZACIÓN TEMPRANA EN PACIENTE POST OPERADO"



P.D. RODRIGUEZ G.

L. LOZANO V.

L. SAAVEDRA R.

2025

Jr. Ancash N° 1271
Barrios Altos, Lima – Perú
Dirección General – Teléfono N° 411-7704
Central Telefónica N° 411-7700
www.incn.gob.pe

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO:
"MOVILIZACIÓN TEMPRANA EN PACIENTE POST OPERADO"

MINISTERIO DE SALUD · INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS · OF. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
I. LLOZANO V.

MINISTERIO DE SALUD · INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS · OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
P.D. RODRIGUEZ G.

MINISTERIO DE SALUD · DIRECCIÓN GENERAL · INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS · VºBº
L. SAAVEDRA R.

DIRECTORIO:

M.C. ESP. LUIS JAIME SAAVEDRA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

M.C. ESP. LEONEL MARIO LOZANO VASQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ABOG. PEDRO DARÍO RODRÍGUEZ GAVANCHO
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

LIC. ESP. KAREN PATRICIA TUCTO VEGAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

ELABORACIÓN:

LIC. ESP. CARMEN ROSA GAMBINI CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍIA

MG. GREGORIA CAPITÁN RIOJA
LIC. ESP. VIRGINIA LUIS GUERRERO
LIC. ESP. MIRELLA MONTALVAN LIVIA
REVISOR ESPECIALISTA DE CONTENIDO

LIC. ESP. VIRGINIA LUIS GUERRERO
REVISOR ORTOTIPOGRÁFICO GRAMATICAL

APOYO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO:

TÉC. ADM. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR
JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

BACH. DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS
ESPECIALISTA EN PROCESOS
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO







Lima, Perú
2025



ÍNDICE

N°	CONTENIDO	PÁG.
	CUADRO DE CONTROL	05
I.	FINALIDAD	06
II.	OBJETIVO	06
	2.1. OBJETIVO GENERAL	06
	2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	06
III.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	06
IV.	NOMBRE DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR	06
V.	CONSIDERACIONES GENERALES	07
	5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS	07
	5.2. CONCEPTOS BÁSICOS	07
	5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS	10
	5.3.1. RECURSOS HUMANOS	10
	5.3.2. INFRAESTRUCTURA DE LA UPS	10
	5.3.3. EQUIPAMIENTO	10
	5.3.4. RECURSOS MATERIALES	11
	5.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO	11
VI.	CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS	11
	6.1. INDICACIONES	11
	6.2. CONTRAINDICACIONES	12
	6.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PROCESO O PROCEDIMIENTO	12
	6.3.1. REQUISITOS	12
	6.3.2. TIEMPO	12
	6.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO	12
	6.4. COMPLICACIONES	15
VII.	RECOMENDACIONES	15
VIII.	ANEXOS	15
	ANEXO 01: IMÁGENES	16
	ANEXO 02: FLUJOGRAMA GENERAL DEL PROCESO	17
IX.	BIBLIOGRAFÍA	18

L. LOZANO V.

P.D. RODRIGUEZ G.

L. SAAVEDRA R.

CUADRO DE CONTROL

ROL	ORGANO	FECHA	V° B°
ELABORADO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	NOVIEMBRE, 2025	
REVISADO POR	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN)	NOVIEMBRE, 2025	L. LOZANO V.
	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	NOVIEMBRE, 2025	P.D. RODRIGUEZ G.
APROBADO	DIRECCIÓN GENERAL	NOVIEMBRE, 2025	L. SAAVEDRA R.

GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO:
"MOVILIZACIÓN TEMPRANA EN PACIENTE POST OPERADO"

I. FINALIDAD

Estandarizar y unificar criterios técnicos, así como brindar estrategias seguras de rehabilitación por parte del personal de enfermería, que favorezcan la funcionalidad del paciente y reduzcan las secuelas e incidencias de eventos adversos mediante la movilización temprana; garantizando la seguridad, calidad y eficiencia de los cuidados brindados al paciente post operado hospitalizado del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN).

II. OBJETIVO

2.1. OBJETIVO GENERAL

Aportar un conjunto de recomendaciones técnicas, basadas en evidencia científica, para los profesionales de enfermería en el proceso de movilización temprana del paciente post operado, con el fin de reducir eventos adversos y complicaciones, mejorar la calidad de vida y promover la calidad del cuidado.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar precozmente los factores de riesgo y la implementación de medidas preventivas y terapéuticas adecuadas.
- Disminuir el riesgo de complicaciones post operatorias del paciente neuroquirúrgico.
- Mejorar la recuperación funcional de los pacientes post operados.
- Establecer un plan de cuidados individualizados que incluya la evaluación temprana de la capacidad de movilización del paciente.
- Reducir el tiempo de hospitalización.

L. SAAVEDRA R.

P.D. RODRIGUEZ G.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La guía técnica se dará a conocer y aplicará en todas las salas de hospitalización de neurología, neurocirugía, neuropediatría, emergencia y áreas críticas con indicación de movilización temprana en pacientes post operados del INCN.

L. LOZANO V.

IV. NOMBRE DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR

- Nombre : Movilización temprana en paciente post operado.
- Tiempo : 20 minutos.

V. CONSIDERACIONES GENERALES

5.1. DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Movilización temprana (MT) es una intervención progresiva eficaz, segura, dando efectos beneficiosos para el paciente post operado.
- La movilidad temprana post-cirugía es una estrategia fundamental que desempeñan un papel crucial en el proceso de recuperación y/o sanación.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

- ***La movilización temprana***: Constituye la implementación de ejercicios físicos y movimientos en los pacientes post operados durante las primeras horas o días después de una cirugía.
- ***La movilización de los pacientes***: Comprende desde las técnicas para colocar y movilizar a los pacientes correctamente en la cama, como aquellos movimientos que se realizan en la habitación o el transporte del enfermo a otros lugares del centro sanitario, a través de sillas de ruedas, camillas o en la propia cama.
- ***La fisioterapia post operatoria***: Es el tratamiento y rehabilitación que se lleva a cabo después de una operación; siendo su objetivo principal restaurar la función física, y mejorar la calidad de vida del paciente.
- ***Terapia física y ocupacional***: Los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales juegan un rol crucial en la planificación e implementación de programas de rehabilitación personalizados que incluyen ejercicios específicos y actividades diarias.
- ***Protocolo de movilización temprana***: Es un conjunto de directrices que establecen cuándo, cómo y por cuánto tiempo se debe realizar la movilización temprana.

  La movilización temprana se ha convertido en uno de los pilares para la mejora de la atención de los pacientes críticos con un notorio impacto favorable en la morbilidad residual.
- ***Recuperación después de una neurocirugía***: Es un proceso que varía según el tipo de intervención, la condición tratada y el estado de salud del paciente pre quirúrgico. La cirugía puede resolver o mejorar la condición neurológica, siendo la rehabilitación post operatoria fundamental para recuperar funciones motoras, cognitivas y sensoriales.

L. SAAVEDRA R.

P.D. RODRIGUEZ G.

L. LOZANO V.

- ***Fases de la rehabilitación tras una neurocirugía:*** La rehabilitación neurológica en pacientes post operados comprende tres fases principales, que dependerán del tipo de cirugía y la respuesta del paciente:

1. **Fase aguda (1- 4 semanas post cirugía)**

   En esta etapa, el objetivo principal es estabilizar al paciente y evitar complicaciones.

   - ***Movilización temprana:*** En cirugías de columna, el paciente puede comenzar a caminar en las primeras 24 – 48 horas para evitar trombosis. Es muy importante en las cirugías cerebrales que afectan áreas motoras, la MT debe iniciarse lo antes posible para evitar atrofia muscular y potenciar la recuperación funcional.
   - ***Ejercicios respiratorios:*** Para evitar infecciones pulmonares post operatorios.
   - ***Evaluación de déficits neurológicos:*** En caso de alteraciones motoras o cognitivas, se diseña un plan de rehabilitación especifico.

2. **Fase subaguda (1-6 meses post cirugía)**

   Es la etapa de rehabilitación activa, donde el paciente trabaja en la recuperación de funciones alteradas:

   - Rehabilitación motora y fisioterapia neurológica.
   - Terapia ocupacional y rehabilitación funcional.
     - ✓ Adaptación a actividades diarias como vestirse, comer o escribir.
     - ✓ Entrenamiento con ayudas técnicas (bastones, sillas de ruedas).
     - ✓ Ejercicios de coordinación y equilibrio para evitar caídas.
   - Rehabilitación cognitiva y del lenguaje.

3. **Fase crónica (más de 6 meses post cirugía)**

   Esta etapa se centra en la consolidación de los avances logrados y en el mantenimiento de la independencia del paciente.

   - ***Beneficios de la movilización temprana:*** La movilización temprana en pacientes post operados tiene múltiples beneficios, tanto físicos como psicológicos. A continuación, se presentan algunos de ellos:

L. SAAVEDRA R.

P.D. RODRIGUEZ G.

L. LOZANO V.

- ***Mejora la fuerza muscular y la funcionalidad:*** La movilización temprana ha demostrado mejorar la fuerza muscular y el nivel de independencia funcional del paciente crítico.
- ***Disminuye la posibilidad de padecer complicaciones:*** La movilización temprana disminuye la posibilidad de padecer trombosis venosa profunda y lesiones por presión, y en pacientes con ventilación mecánica, disminuye las neumonías asociadas.
- ***Reduce la estancia hospitalaria:*** La movilización temprana puede reducir la estancia hospitalaria y en los servicios neurocríticos.
- ***Mejora la calidad de vida:*** La movilización temprana puede mejorar los resultados en términos de calidad de vida y la movilidad funcional de los pacientes tras su alta.
- ***Promueve el bienestar psicológico:*** La movilización temprana también tiene un impacto positivo en el bienestar psicológico del paciente crítico, ya que la inmovilidad prolongada puede provocar ansiedad, depresión y deterioro del estado de ánimo. Al permitir que los pacientes participen activamente en su proceso de recuperación a través de la movilización, se promueve un sentido de control y empoderamiento.

- ***Técnicas de movilización temprana:*** Las técnicas de movilización temprana varían según el tipo de cirugía y el estado del paciente.

L. SAAVEDRA R.

Existen diversas técnicas de movilización temprana que se pueden utilizar en los pacientes post operados, en el cual algunas de ellas son:

P.D. RODRIGUEZ G.

- ***Ejercicios de respiración profunda:*** Estos ejercicios ayudan a expandir los pulmones y prevenir complicaciones respiratorias. Se recomienda realizar respiraciones profundas.
- ***Ejercicios isométricos****:* Estos ejercicios, que implican la contracción y relajación de los músculos sin mover las articulaciones, son útiles para mantener la fuerza muscular en pacientes que están limitados en su movilidad.

L. LOZANO V.

- ***Movilización pasiva y activa de las extremidades****:* Consiste en mover las extremidades del paciente de forma pasiva o con la ayuda del propio paciente, con el objetivo de prevenir la rigidez articular y mejorar la circulación sanguínea.

- ***Giro lateral activo***: Consiste en ayudar al paciente a girar su cuerpo hacia un lado y luego hacia el otro, con el objetivo de prevenir la aparición de úlceras por presión y mejorar la ventilación pulmonar.
- ***Ejercicios en la cama***: Consiste en realizar ejercicios de fortalecimiento muscular y estiramientos mientras el paciente se encuentra en la cama, con el objetivo de mejorar la fuerza muscular y la movilidad articular.
- ***Sentarse en la cama***: Consiste en ayudar al paciente a sentarse en la cama, con el objetivo de mejorar la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio.
- ***Transferencias de la cama a la silla y viceversa***: Consiste en ayudar al paciente a moverse de la cama a una silla y viceversa, con el objetivo de mejorar la capacidad funcional y la independencia.
- ***Ambulación***: Consiste en ayudar al paciente a caminar, con el objetivo de mejorar la capacidad funcional y la independencia.

5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS

5.3.1. RECURSOS HUMANOS

- Lic. de enfermería general.
- Lic. de enfermería especialista.

5.3.2. INFRAESTRUCTURA DE LA UPS

- Salas de hospitalización de neurología, neurocirugía, neuropediatria, servicios de neurocríticos.

5.3.3. EQUIPAMIENTO

- Cama clínica articulada con barandales adecuados.
- Cama eléctrica.
- Contenedor para residuos comunes.
- Contenedor para residuos contaminados.
- Silla.
- Sábanas.
- Soleras.
- Almohadas y/o cojines.

MINISTERIO DE SALUD · INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS · OF. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
L. LOZANO V.

MINISTERIO DE SALUD · INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS · OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
P.D. RODRIGUEZ G.

MINISTERIO DE SALUD · DIRECCIÓN GENERAL · INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS · V°B°
L. SAAVEDRA R.

5.3.4. RECURSOS MATERIALES

A. MATERIAL MÉDICO NO FUNGIBLE

- Biombos de tres cuerpos.
- Grúas.
- Pasador.

B. MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE

- Vestimenta de bioseguridad:
  - Gorro 01
  - Mascarilla N95 01
  - Mandil descartable 01
  - Guantes barrera N° 7 y/o N° 8 01

C. OTROS

- Historia clínica (indicación médica).
- Anotaciones de enfermería.
- Toalla.
- Jabón
- Clorhexidina 2%.
- Lapicero rojo y azul.

L. SAAVEDRA R.

5.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO

- No aplica.

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

6.1. INDICACIONES

P.D. RODRIGUEZ G.

L. LOZANO V.

A. ABSOLUTAS

En paciente post operado, la MT no tiene indicación absoluta, su inicio y tipo deben ser evaluados individualmente por el equipo médico, considerando el estado del paciente y el tipo de cirugía.

B. RELATIVAS

- Aneurisma resuelto (Función neurológica estable y capacidad para movilizar extremidades).
- Índices hemodinámicos estables (PAM dentro del rango normal y una frecuencia cardiaca).
- Función respiratoria adecuada.

- Presión intracraneana estable.
- Estado neurológico estable.
- Lesiones asociadas (se debe tener precauciones en pacientes con fracturas inestables o lesiones medulares.

6.2. CONTRAINDICACIONES

A. ABSOLUTAS

- Inestabilidad hemodinámica severa (PAM menor a 60 o mayor a 110 mmHg.
- Frecuencia cardiaca menor a 50 o mayor de 100 x minuto arritmias.
- Inestabilidad respiratoria grave (requerimiento de O2 elevado)
- Dolor severo durante la movilización (suspender MT).
- Trombosis venosa central y/o tromboembolismo pulmonar no tratados.
- Hemorragia activa.
- Heridas quirúrgicas abiertas o inestables.
- Alteraciones graves de la coagulación.
- Hipertensión intracraneal.

B. RELATIVAS

- Inestabilidad hemodinámica.
- Inestabilidad respiratoria (pacientes con altas dependencia de O_2)
- Infección activa.
- Complicaciones quirúrgicas (hemorragia o dehiscencia de heridas).
- Estado neurológico (alteraciones de estado de consciencia).

L. SAAVEDRA R.

6.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO

6.3.1. REQUISITOS

- Indicación médica. Prescrito en H.C.

P.D. RODRIGUEZ G.

6.3.2. TIEMPO

- 20 minutos.

L. LOZANO V.

6.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO

A. PREVIO AL PROCEDIMIENTO

Evaluación y preparación del paciente.

1. Compruebe identidad del paciente.
2. Eduque al paciente y a su familia sobre los beneficios y la importancia de la movilización temprana.

3. Realice baño e higiene y cambio de ropa, antes de iniciar el proceso.
4. Evalué el estado neurológico del paciente post operado para poder establecer un plan, determinar su capacidad de iniciar (MT), y tener en cuenta los criterios de seguridad para su interrupción.
5. Verifique tipo de cirugía y día de post operatorio del paciente.
6. Evalué el nivel de dolor del paciente, si este lo presentara.
7. Verifique indicación médica para inicio de MT.
8. Evalué si el paciente se encuentra con apoyo ventilatorio, presenta dispositivos invasivos (drenes, DVE, CVC, TET, TQ, VM).
9. Realice la preparación física y brinde apoyo emocional.
10. Realice lavado de manos según Norma Técnica N°RM N°255-2016/MINSA.
11. Coloque biombo de tres cuerpos en la unidad el paciente.

Preparación de material

1. Biombos de tres cuerpos.
2. Sábanas, solera.
3. Almohadas, cojines.
4. Grúas.

B. DURANTE EL PROCEDIMIENTO

1. Colóquese EPP.
2. Realice lavado de manos según Norma Técnica N°RM N°255-2016/MINSA.
3. Adopte posturas adecuadas y ergonómicas, para el paciente como para el profesional.
4. Proteja zona quirúrgica y drenes si presenta antes de la MT.
5. Preserve la intimidad del paciente en todo momento (biombos).
6. Inicie las técnicas de movilización temprana, según el tipo de cirugía y el estado del paciente.
7. Indique al paciente a realizar respiraciones profundas varias veces al día.
8. Realice movilización pasiva y activa de las extremidades.
9. Realice giro lateral activo (girar su cuerpo de un lado al otro) en pacientes impedidos de movilizarse por sí mismos.
10. Realice ejercicios mientras el paciente se encuentre en cama.
11. Ayude al paciente a sentarse en la cama.

L. SAAVEDRA R.

P.D. RODRIGUEZ G.

L. LOZANO V.

12. Asista al paciente a trasladarse de la cama a la silla y viceversa.
13. Ayude al paciente a levantarse de la cama e iniciar la deambulación temprana postcirugía, según indicación médica.
14. Movilice e indique cambio de posición cada 2 horas en pacientes con deterioro de consciencia y/o con limitación de la movilidad.
15. Observe si paciente presenta reacción adversa a la movilización y detenga el proceso, y reevaluar a las 24 horas para su reinicio.
16. Asista y supervise los ejercicios y actividades de movilización para asegurar que se realicen de manera segura.

C. DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

1. De comodidad y confort finalizada la MT.
2. Verifiqué que la zona quirúrgica y los dispositivos invasivos estuvieran correctos después de finalizar la (MT).
3. Descarte EPP utilizados en contenedores, según corresponda.
4. Realice lavado de manos clínico, según Norma Técnica N°RM N°255-2016/MINSA.
5. Monitoree signos vitales y oximetría si el paciente lo requiere.
6. Evalué estado neurológico del paciente, si presenta cambio finalizada la movilización.
7. Evalué si el procedimiento cumplió el objetivo esperado.
8. Comunique a médico tratante si paciente presenta incidencias y/o complicaciones a consecuencia de la movilización.
9. Registre incidencias e intervenciones en anotaciones de enfermería.
10. Elabore los diagnósticos de enfermería, según corresponda:

- ✓ 00085 Riesgo de deterioro de la movilidad física.
- ✓ 0034 Riesgo de lesión por presión del adulto.
- ✓ 00291 Riesgo de trombosis.
- ✓ 00464 Riesgo de deterioro de la recuperación quirúrgica.
- ✓ 00031 Limpieza ineficaz de las vías aéreas.

L. SAAVEDRA R.

P.D. RODRIGUEZ G.

L. LOZANO V.

PROCESO O PROCEDIMIENTO		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**DURACIÓN**
	GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO: MOVILIZACIÓN TEMPRANA EN PACIENTE POST OPERADO	
Lic. de enfermería general. Lic. de enfermería especialista.	A: Previo al procedimiento.	3 minutos
	B: Durante el procedimiento.	15 minutos
	C: Después del procedimiento.	2 minutos
	Tiempo total de Duración (Aproximada)	**20 minutos**

6.4. COMPLICACIONES

Cuando no se utilizan las adecuadas técnicas de movilización:

- Posturas anormales en las extremidades.
- Lesión de articulaciones y contracturas musculares por movimientos forzados.
- Aparición de dolor intenso en las articulaciones que empeora con la movilización.
- Lesiones cutáneas por mala técnica de la movilización. (fricciones).

VII. RECOMENDACIONES

- La movilización temprana es crucial en el post operados para una recuperación rápida y efectiva.
- La evaluación debe ser individualizada, cada paciente es único por lo que la movilización debe adaptarse a sus necesidades y capacidades individuales,
- La decisión de movilizar o no a un paciente con contraindicaciones relativas debe ser tomado por un profesional de la salud calificado, considerando el estado general del paciente, la gravedad de la contraindicación y los beneficios esperados de la movilización.
- Antes de inicio de MT se debe colocar la cama del paciente en posición horizontal y asegurar los frenos.
- Tener al alcance las almohadas y/o dispositivos específicos a utilizar en la movilización.
- Antes del inicio tener precauciones en proteger la zona quirúrgica, drenajes, sondas, y otros dispositivos que pueda presentar el paciente.
- Se recomienda movilizar al paciente a la posición seleccionada, evitando fricciones y sacudidas bruscas.
- Se recomienda involucrar a los cuidadores y familiares en el proceso de movilización del paciente y proporcionarles las herramientas necesarias para garantizar una atención adecuada en el hogar.
- El personal de enfermería debe estar preparado para realizar la movilización correctamente para prevenir lesiones en el paciente y evitar que la enfermera (o) que realiza el proceso se lesione.

VIII. ANEXO

ANEXO 01 : IMÁGENES

ANEXO 02 : FLUJOGRAMA GENERAL DEL PROCESO

ANEXO 01

IMÁGENES



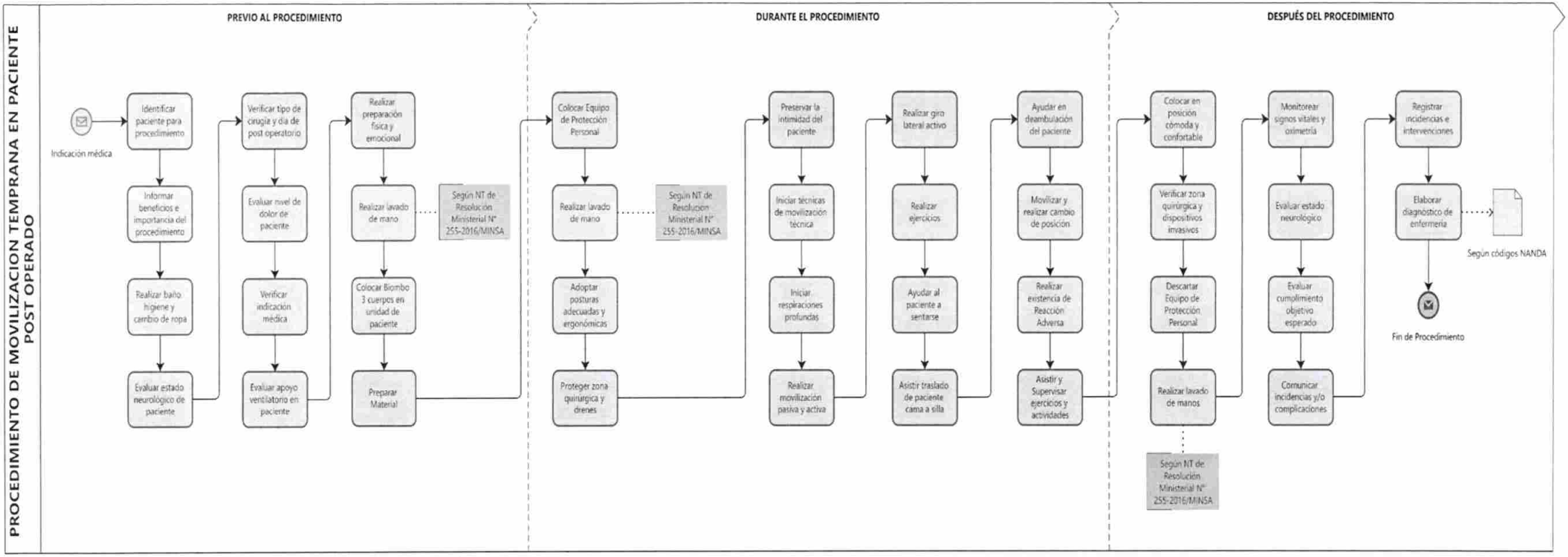


L. LOZANO V.

P.D. RODRIGUEZ G.

L. SAAVEDRA R.

ANEXO 02
FLUJOGRAMA GENERAL DEL PROCESO



L. LOZANO V.

P.D. RODRIGUEZ G.

L. SAAVEDRA R.

IX. BIBLIOGRAFÍA

1. revistamedica.com ›analisis-tecnicas-movilizacion-temprana-postoperatorioTécnicas de movilización temprana en el postoperatorio
2. cirugiasvital.com › movilidad-y-reposo-postoperatorioMovilidad y reposo postoperatorio: Claves para la recuperación
3. www.draojedafisioterapia.com › blog › importancia-movilidad-post-cirugíaMovilidad Post-Cirugía: Recuperación Activa para un Mejor Reposo
4. fisioterapiaiglesias.com ›fisioterapia-postoperatoria-recupera-tu-movimiento-yFisioterapia postoperatoria: recupera tu movimiento y bienestar
5. www.elsevier.es › es-revista-enfermeria-intensiva-142-articulo-algoritmoAlgoritmo de movilización temprana para el paciente crítico ...
6. repository.unab.edu.co › bitstream › handleMOVILIZACIÓN TEMPRANA Y REHABILITACIÓN FÍSICA DE PACIENTES EN LAS...
7. neurocirugiadiamantopoulos.com ›rehabilitacion-y-recuperacion-tras-una-neurocirugiaRecuperación tras una neurocirugía - Equipo Diamantopoulos NANDA

MINISTERIO DE SALUD – INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS – OF. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
L. LOZANO V.

MINISTERIO DE SALUD – INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS – OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
P.D. RODRIGUEZ G.

MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN GENERAL – INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
L. SAAVEDRA R.